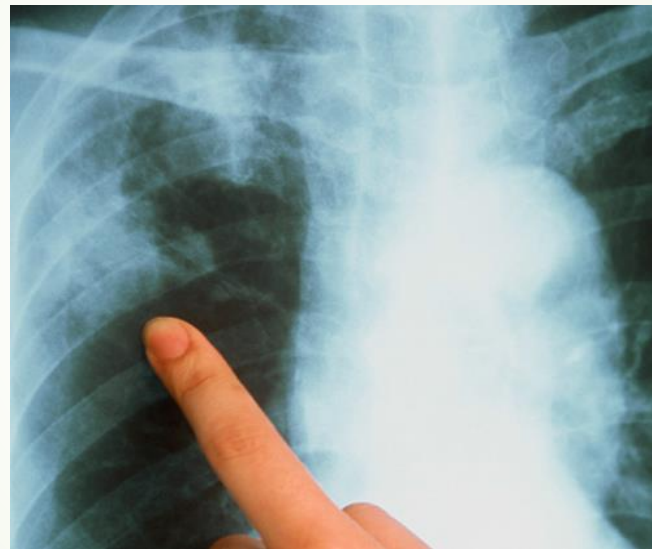


Suppurations Pulmonaires



Pr Belala Redouane

Maître de conférence en pneumologie

Hôpital militaire régionale universitaire
Constantine



plan

- Définition
- Intérêt de la question
- Mécanisme de survenue
- Diagnostic positif
- Diagnostic différentiel
- Formes cliniques
- Evolution, complications
- Conduite à tenir
- Pronostic



Définition

- Abscès du poumon = suppuration collectée dans une cavité néoformée creusée dans un parenchyme pulmonaire par une inflammation non spécifique

II-Intérêt de la question

- **Fréquence :**
 - ↘ depuis l'avènement des ATB
 - Conditions favorisantes
 - Mortalité reste importante
- **Diagnostic :** dgc précoce ⇒ TRT précoce
- **Thérapeutique :** décision TRT urgente
- **Pronostic :** dépend
 - Précocité du TRT
 - Qualité du TRT
 - Terrain



III- Mécanisme de survenue :

1-Inhalation de matériel septique

- Provenant des VAD
- Mauvais état bucco-dentaire
- Atteinte neurologique

2- Voie hématogène

- au cours d'une septicémie
- ou par embolies septiques

3-secondaire à une cause locale

- à partir d'une suppuration sous phrénique sur sténose
- suppuration d'un kyste hydatique rompu

1 -Diagnostic positif





Circonstances de découverte

- tableau de pneumopathie inf aigue
- tableau de suppuration compliquant une pneumopathie virale ou bactérienne
- tableau de décompensation d'une tare préexistante
- tableau de détresse respiratoire aigue
- dans les suites immédiates d'une intervention chirurgicale

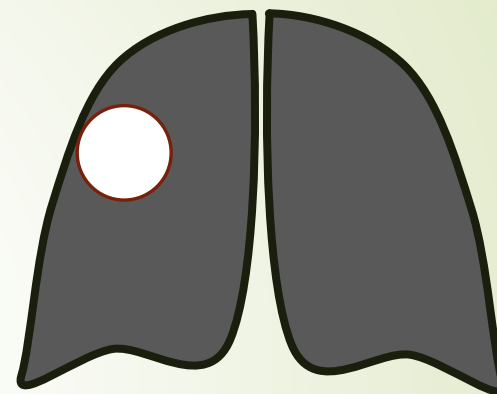


Recherche de facteurs de risque

- diabète
- éthylisme
- immunodéprimés, SIDA
- infections des VAD
- atteinte neurologique
- foyer infectieux extra-pulmonaire
- recherche d'une cause locale

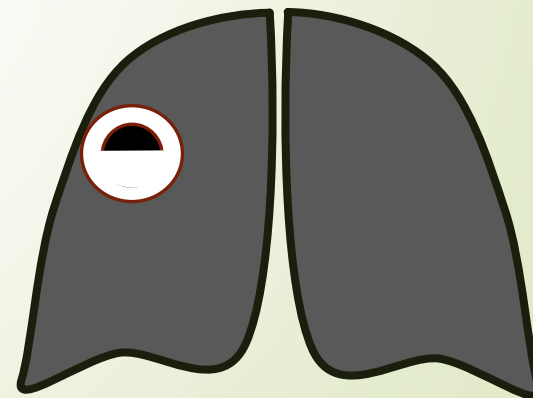
Stades radio-cliniques

➤ Stade d'abcès à foyer fermé



➤ Stade d'abcès vomiqué

➤ Stade d'abcès à foyer ouvert



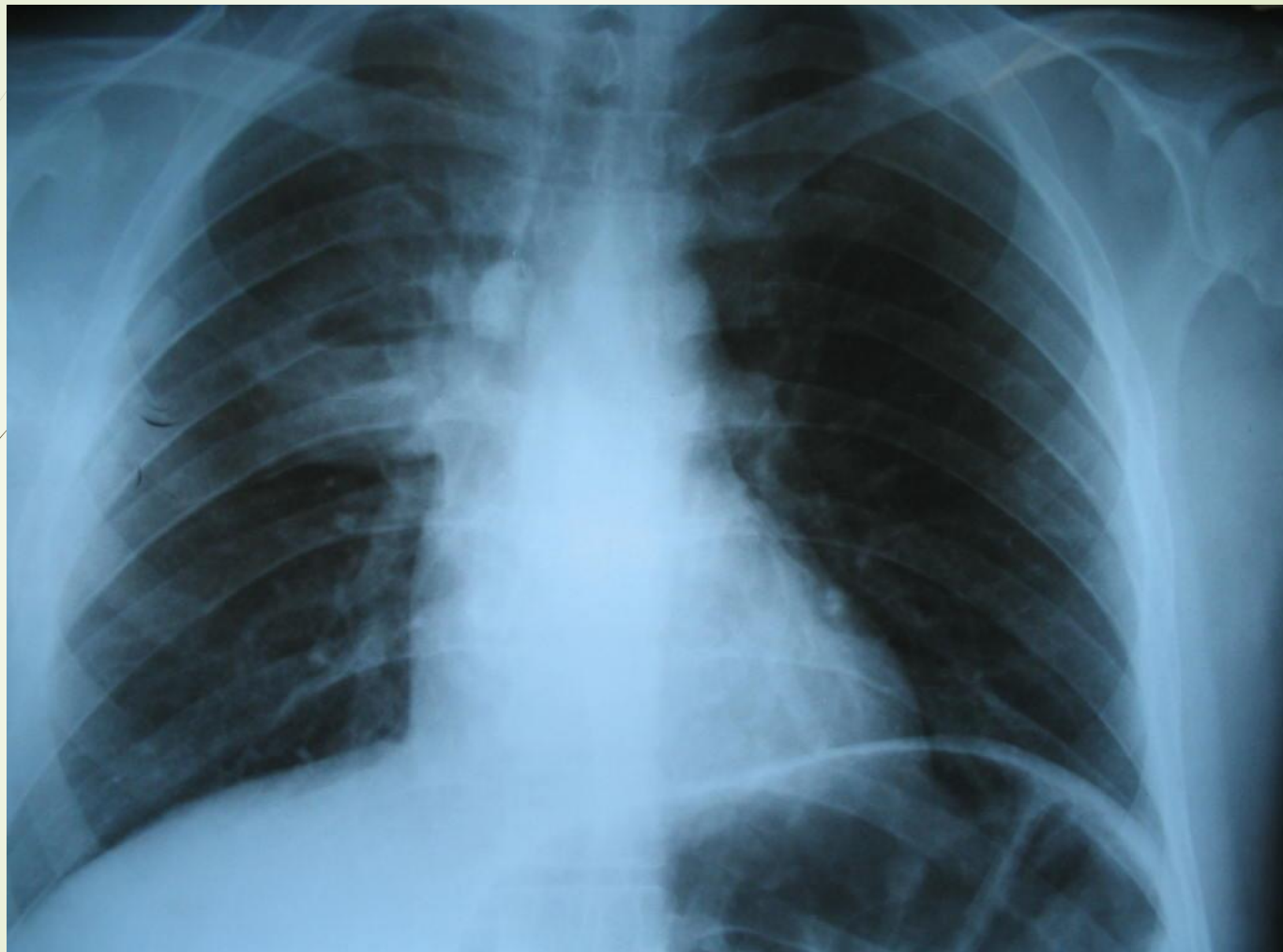
Examens para-cliniques

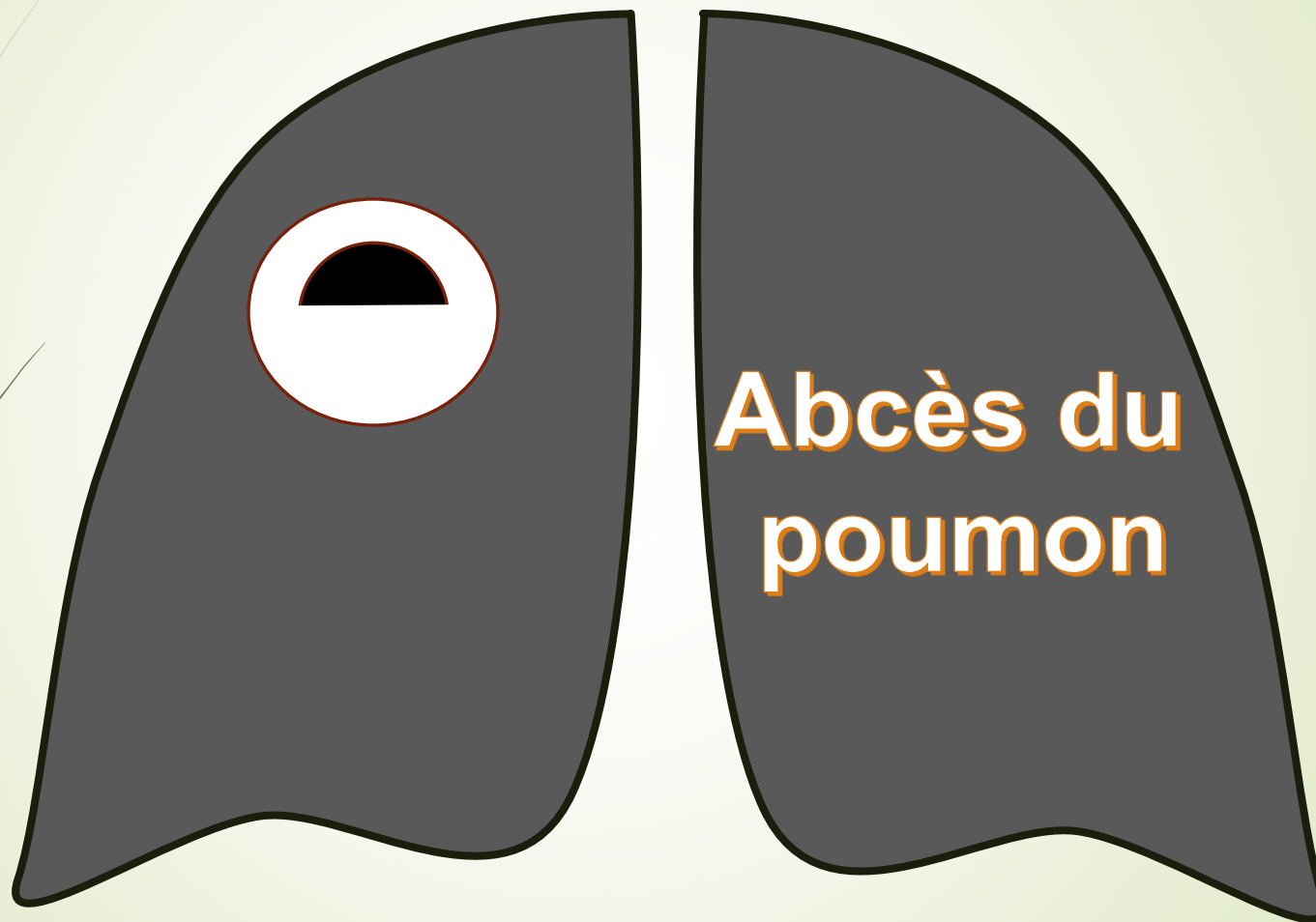




1- Imagerie

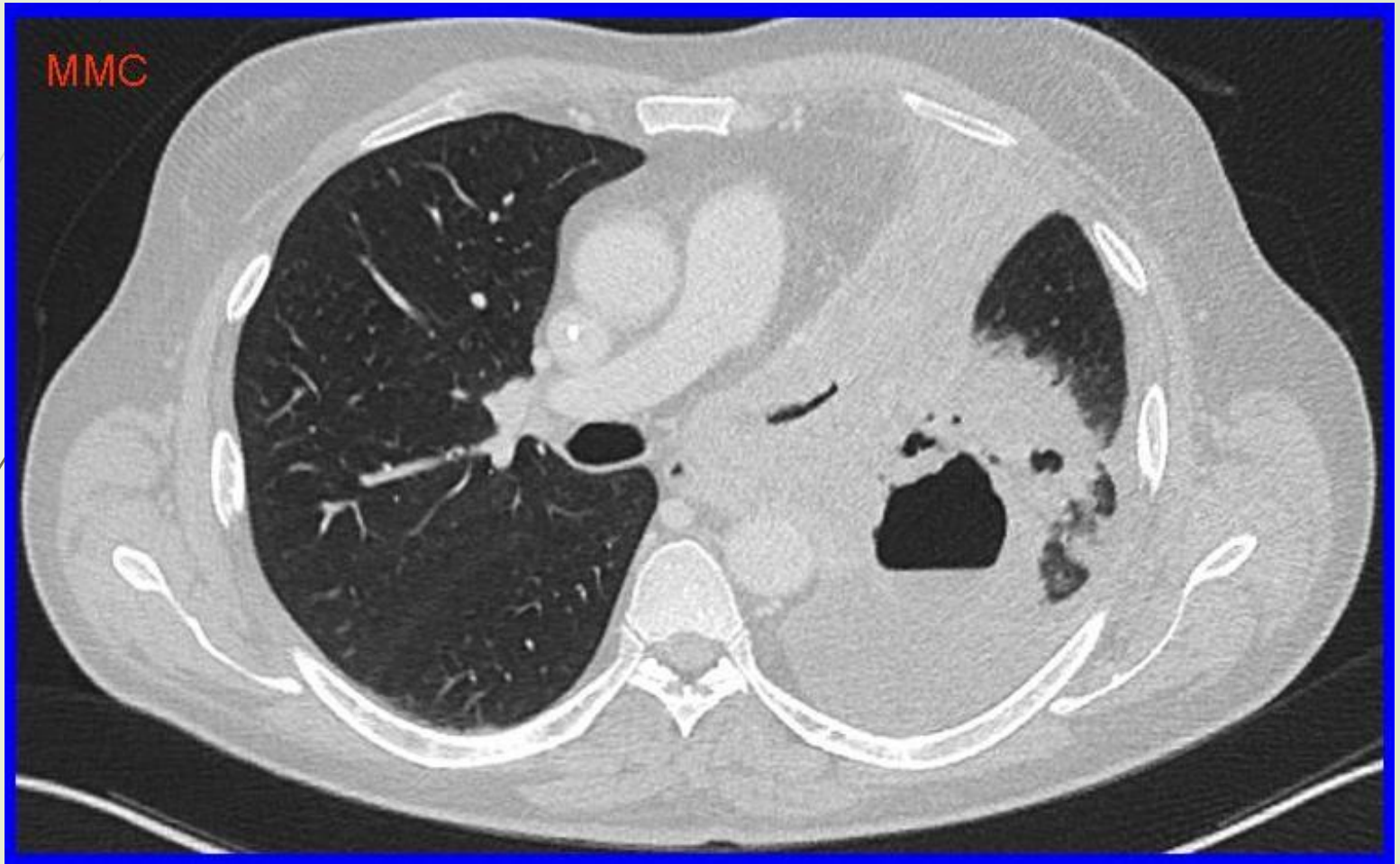
- Radio du thorax (F+P)
- TDM dans les formes difficiles

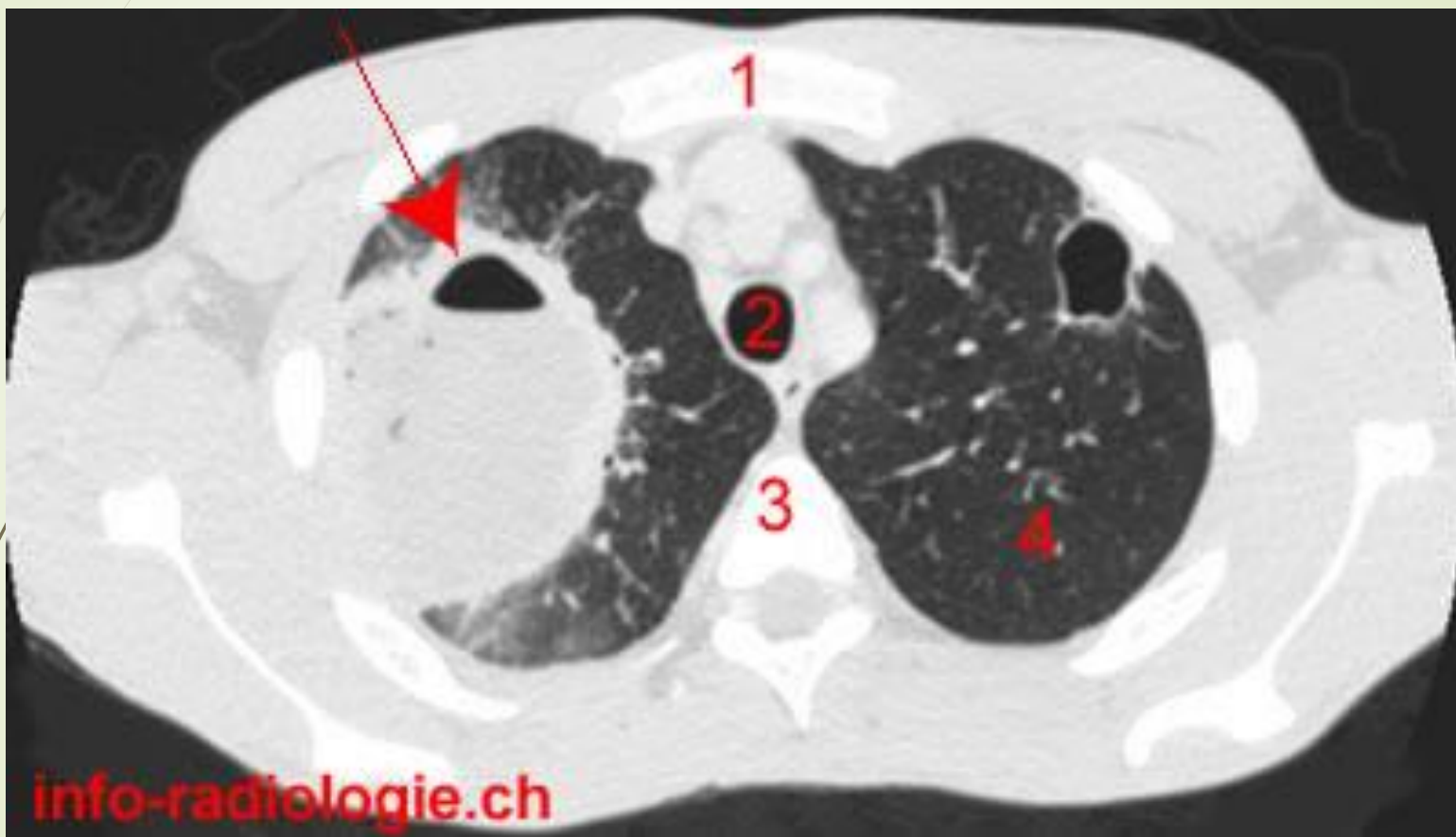


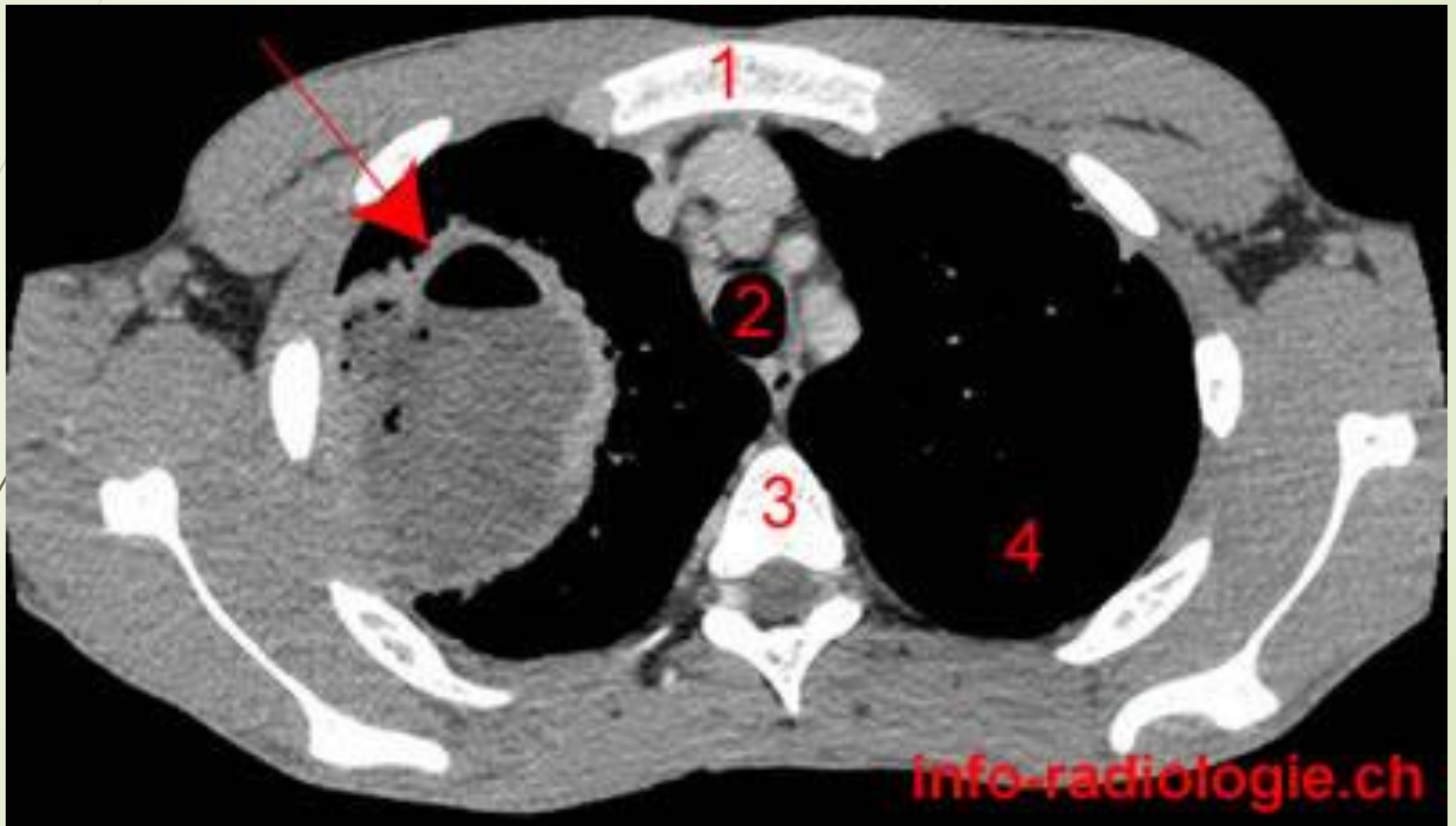


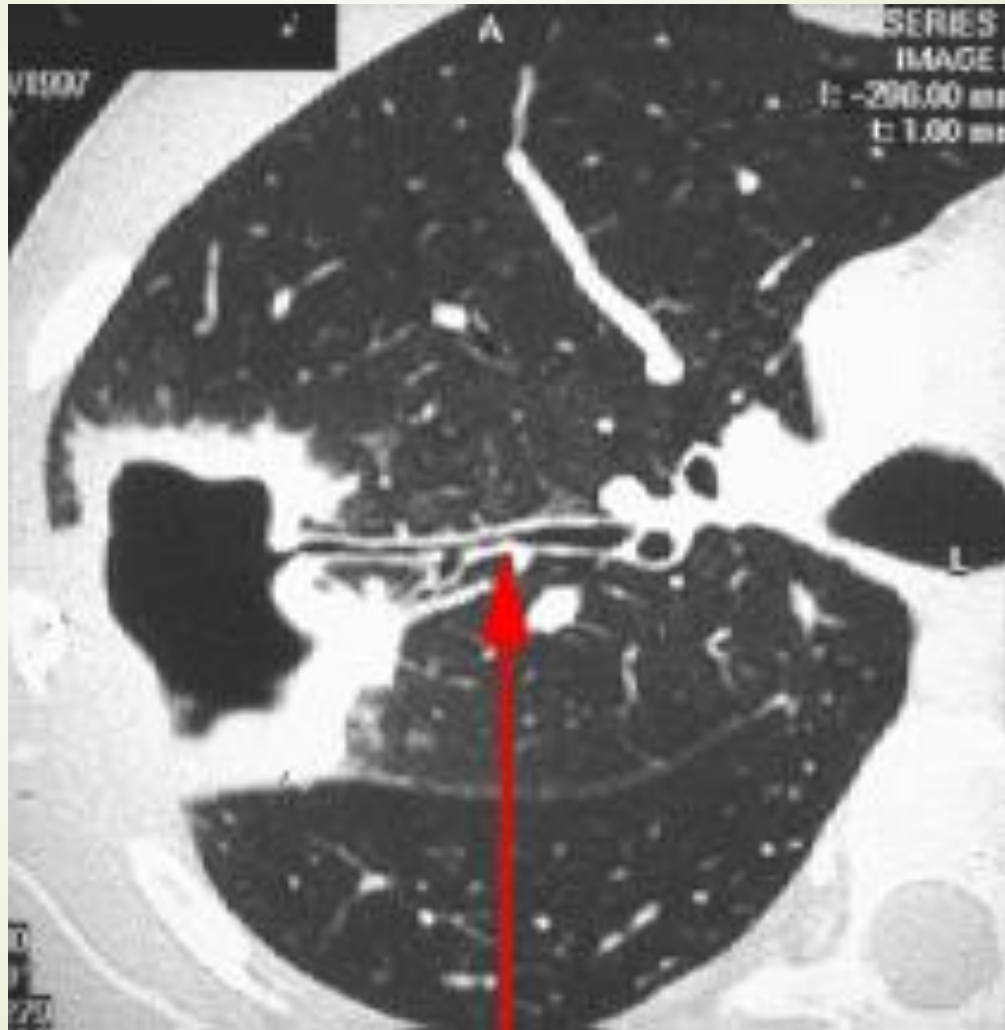


TDM









2- Etude bactériologique

- avant tout TRT
- Bacilloscopie des crachats
- Hémocultures répétées ++++
- Ponction pleurale si EPL
- Uroculture
- Ponction trans-trachéale (réanimation)
- Mise en évidence d'Ag bactériens solubles (sang, urines, expectoration)



3- Fibroscopie bronchique

- Prélèvements
- Vérifie l'intégrité de l'arbre aérien
- L'extraction d'un corps étranger
- L'évacuation des sécrétions



4- Autres examens

- Radio des sinus
- Panoramique dentaire
- Fibroscopie digestive (si contexte évocateur)

Diagnostic différentiel

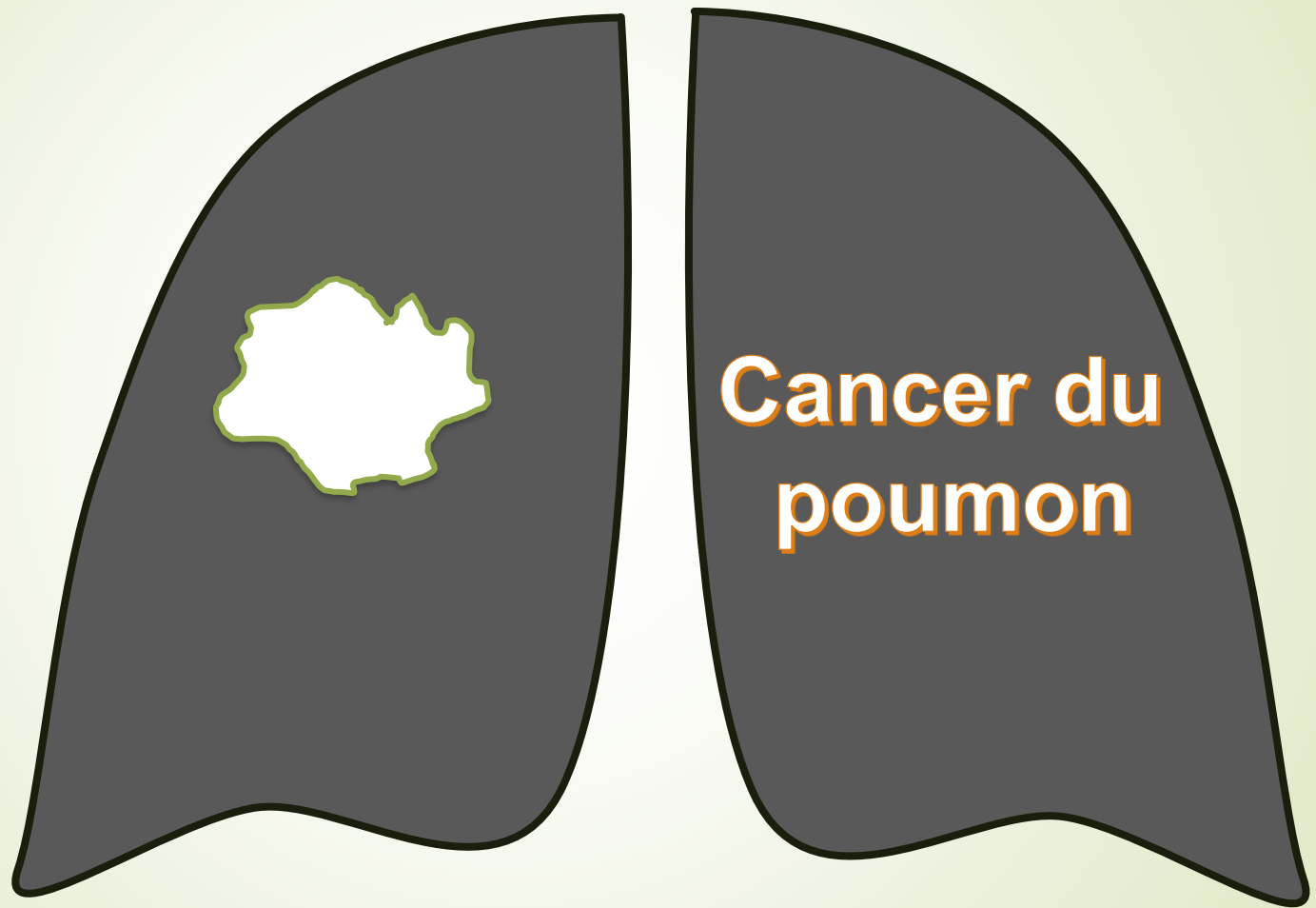


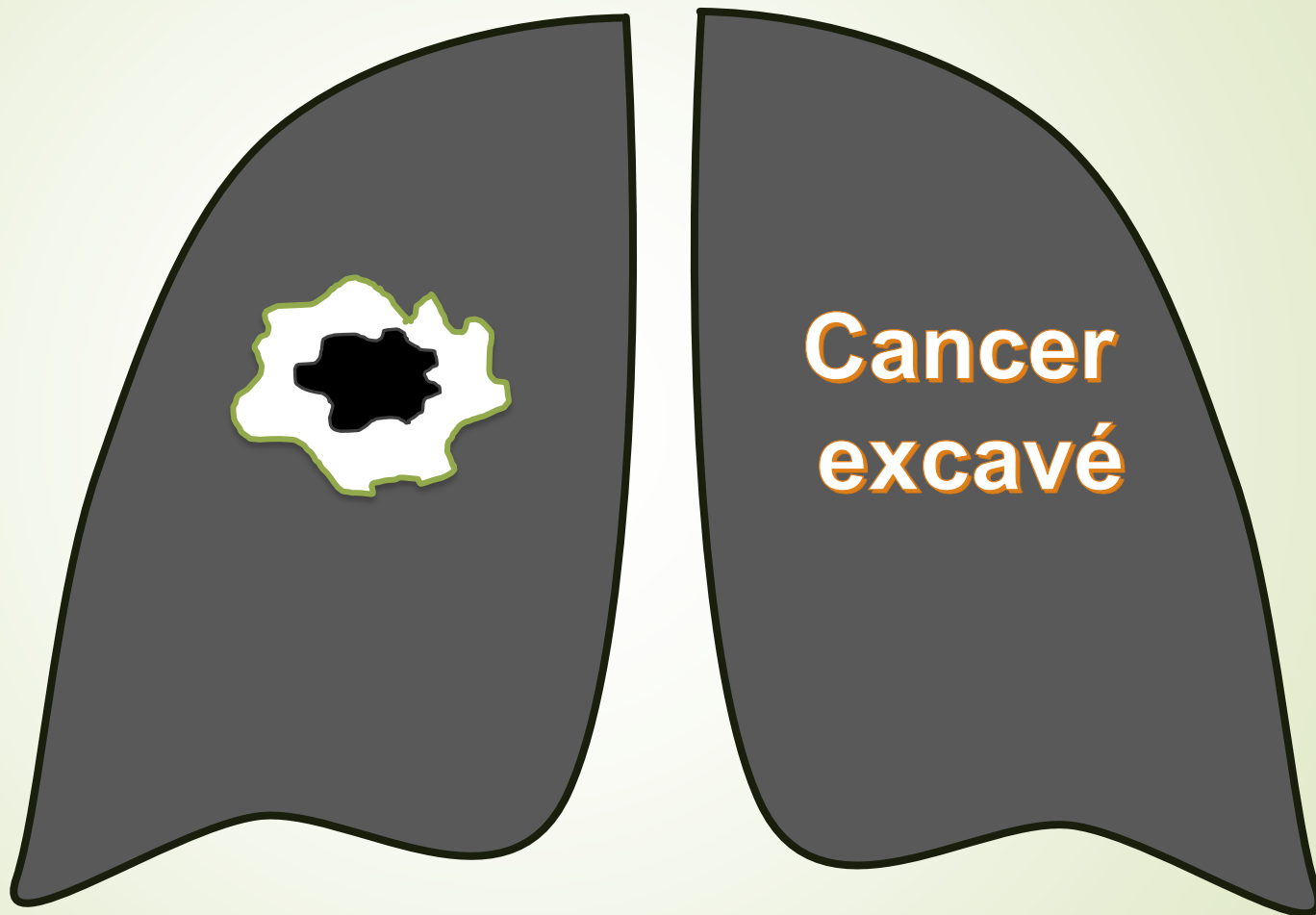
- ***Au stade initial***

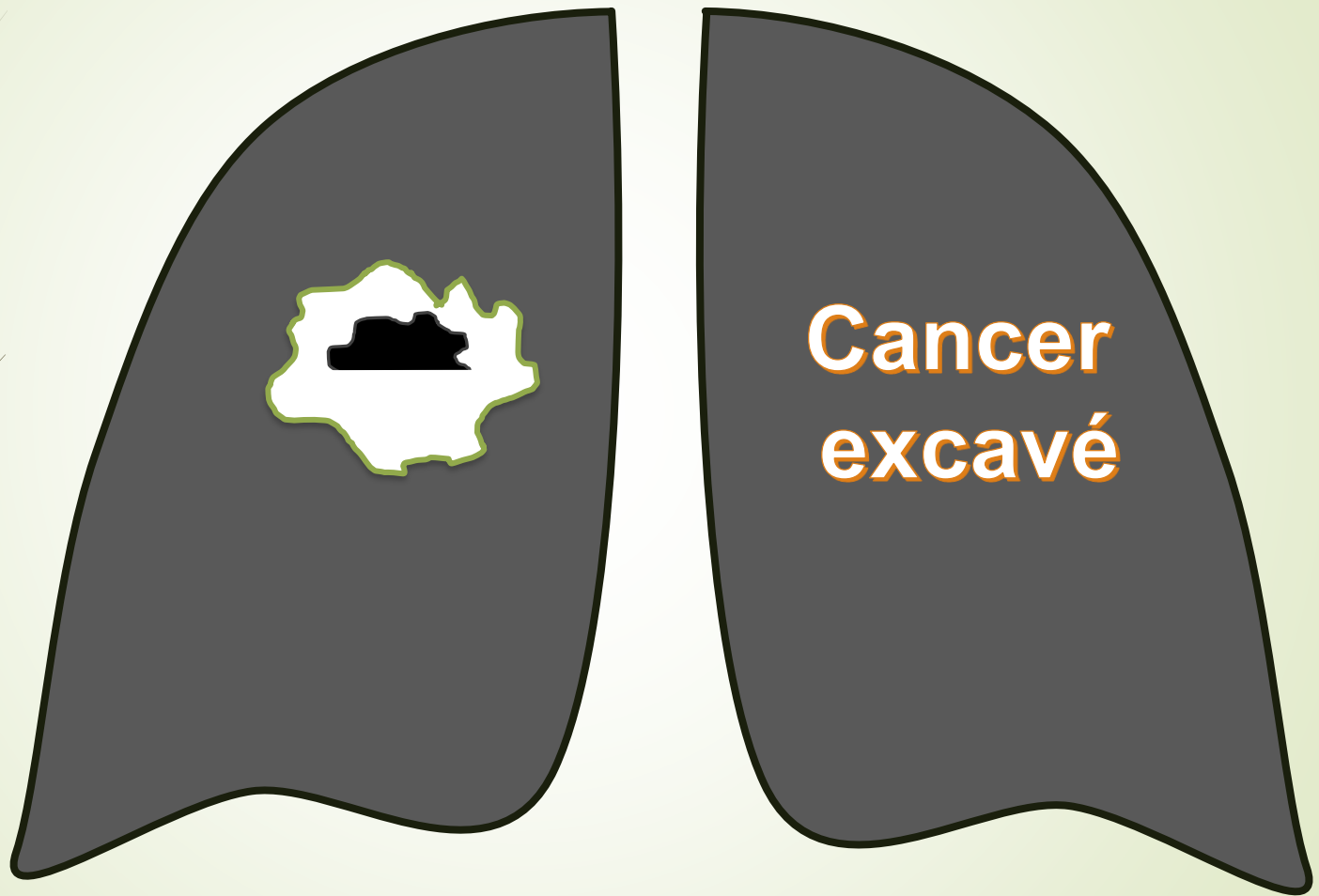
- Pneumopathie virale, bactérienne
- Tuberculose pulmonaire

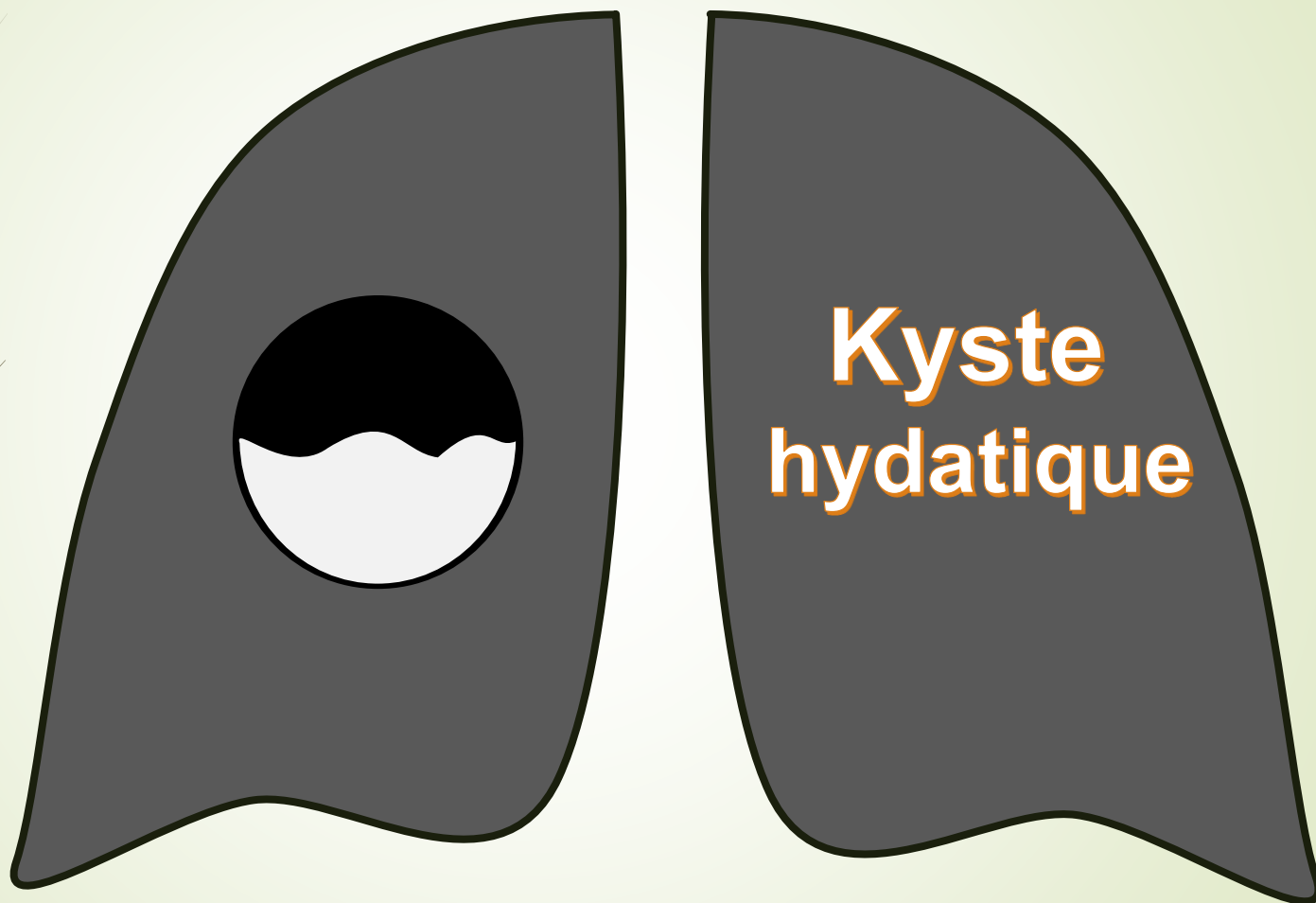
- ***Au stade de l'expectoration purulente + image mixte***

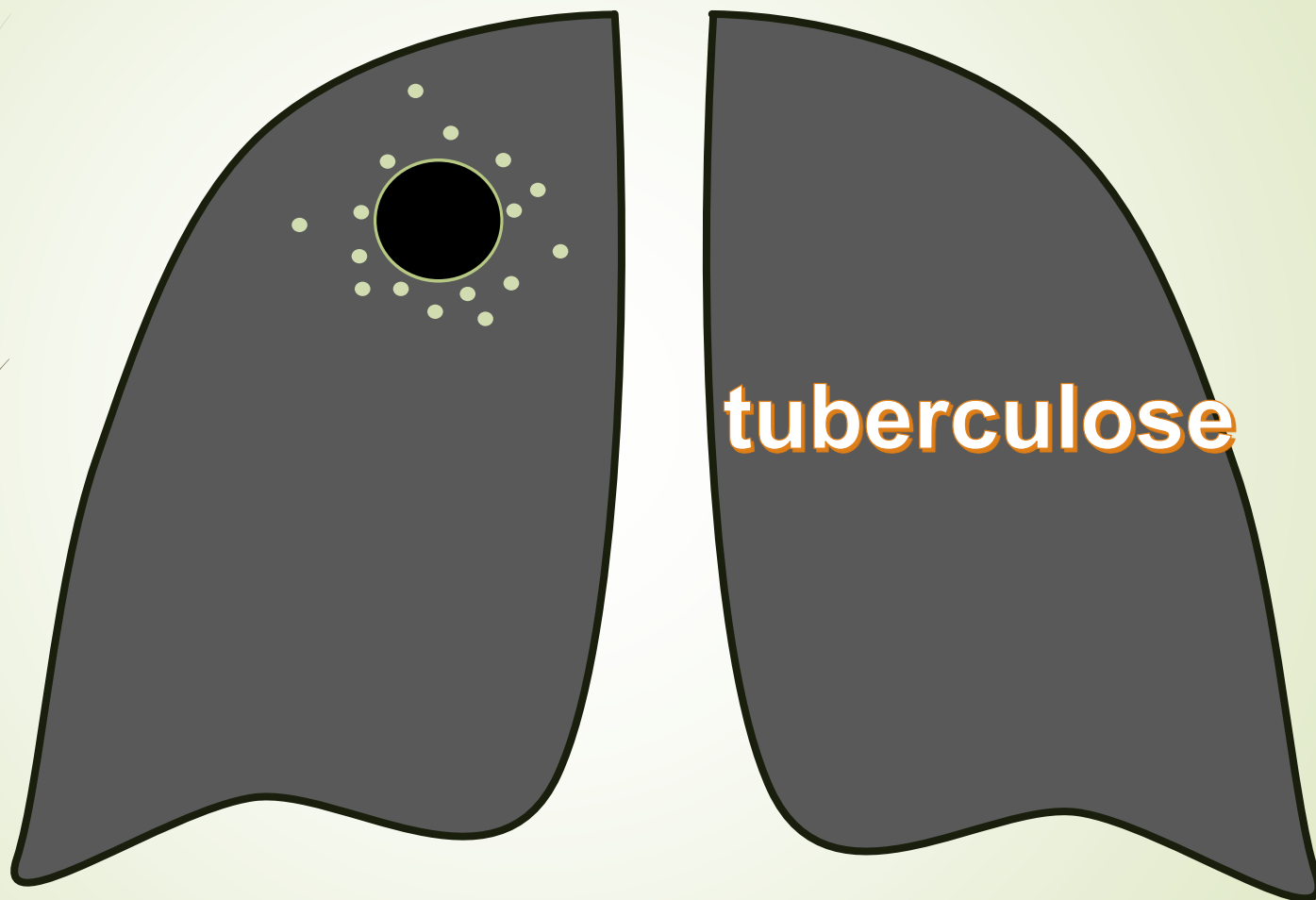
- Tuberculose pulmonaire
- Cancer bronchique
- Pleurésie
- KH













V- FORMES CLINIQUES

- Formes décapitées
- Formes suraigües (alcooliques)
- Formes chroniques
- Formes selon le germe :
 - pneumocoque
 - anaérobies
 - klebsiella
 - staphylocoque

VI- EVOLUTION, COMPLICATIONS :

Sans traitement

➔ Complications mortelles :

- abcès cérébral
- Hémoptysie
- pyoPNO

Avec traitement

- souvent favorable ➔ cicatrisation
- séquelles +/- gênantes :
 - DDB localisée
 - Cavité résiduelle (surinfection, aspergilisation)
 - Bulle d'emphysème



CONDUITE à TENIR :

- Hospitalisation
- Éliminer une tuberculose
- Rechercher
 - terrain
 - cause locale
 - infection à distance
 - porte d'entrée
- Isoler et identifier le germe
- Antibiogramme
- ATB probabiliste adaptée ensuite en f(x) de l'antibiogramme

TRAITEMENT :

Buts

- Evacuer le pus
- Maîtrise de l'infection par l'antibiothérapie

➤ Moyens

➤ **TRT médicale**

➤ **a-Traitement général**

- ATBérapie :
- TRT de l'état général
- TRT d'une tare

➤ **b- Traitement local**

➤ **TRT chirurgicale**



ATBérapie

- démarrée juste après prélèvements
- Double ATB synergique bactéricide
- Probabiliste au début
- Voie IV
- Posologie en f(x) du poids
- Durée : 4- 6 semaines
- Relais après voie orale après apyrexie et amélioration clinique



TRT de l'état général

- Renutrition orale ou parentérale
- Régime hypercalorique , hyperprotidique
- Equilibre hydro-électrolytique



b- Traitement local

- Evacuation du pus : spontanément
- Kinésithérapie la 1^{ère} semaine dès que l'état général s'améliore , évite les séquelles , drainage bronchique
- TRT d'une porte d'entrée



TRT chirurgica

- 10 % des cas
- Exérèse des cavités résiduelles
- Précédé d'un bilan d'opérabilité



Paramètres de surveillance

- Température (2 fois /j)
- Volumétrie des crachats
- Courbe pondérale
- FNS : 1 fois /sem
- Rx du thorax :1 fois /sem



Critères de guérison

➤ *Clinique :*

- Apyrexie durable
- Tarissement durable de l'expectoration appréciable
- Prise de poids

▪ *Radiologie*

- Restitution ad-integrum
- Images stellaires immuables
- Clarté sans niveau

➤ *Biologie*

- FNS se normalise



PRONOSTIC :

- Bon → suppuration sujet sain
- Réserve → cadre poly-pathologies (immunodéprimés, hôpital)